（四）切口

1.分类

I类清洁切口	甲状腺手术　过了6-8h(细菌明显繁殖),属于污染的切口
II类可能污染切口	胃手术、皮肤不易彻底消毒处（会阴）、6 小时内伤口清创术缝合、新缝合切口再度切开
III类污染切口	阑尾化脓穿孔行切除术、绞窄坏死肠管切除术



2.愈合（三甲医院就是要让III类切口甲级愈合）

甲级：优良

乙级：有炎症、没化脓

丙级：化脓、需引流

3.并发症　甲状腺术后出血压迫气管,立即床旁抢救,拆线敞伤口,止血清血肿,止血充分也应常规引流

①切口积血（最常见）：隆起、肿胀、血液外渗。甲状腺术后引起的颈部积血有窒息危险

②切口血清肿：术中切断较多的**淋巴管**（乳房、腹股沟区手术）。皮下血清肿空针抽吸+敷料压迫（但腹股沟区禁止空针抽吸）

③切口感染：红肿、脓液流出。拆除缝线、**敞开引流**、清创、抗生素、细菌培养

④切口裂开：多在**咳嗽、腹胀后流出淡红色液体**。完全裂开（全层裂开+肠或网膜脱出）无菌敷料覆盖切口+**减张缝合**。适当的腹部加压包扎可预防　组织液

真题解析·围术期

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2016N84 A 以下关于高血压患者术前的处理中，正确的是

A.术前两周停用降压药　戒断综合征/反跳现象

B.入手术室血压骤升，应果断停止手术　紧张恐惧

C.血压降至正常后再行手术　140/90

D.血压 160/l00mmHg 以下不予处理　140/90

2. 2020N95-96 A 女性，65 岁。胆囊结石 10 年，近来反复发作胆绞痛，要求手术治疗。有高血压、糖尿病病史，服药血压维持在 150-160/85-95mmHg，空腹血糖 7.3mmol/L。

95.患者术前处理措施中，正确的是

A.血压降至 130/90mmHg 再手术　140/90

B.血糖降至 6.1mmol/L 再手术　5.6-11.2轻度升高状态

C.血压、血糖均正常后再手术

D.无需特殊处理，可手术

96.患者行腹腔镜胆囊切除术，手术顺利。术后前 3 天引流管微黄清亮液体 15-20ml/日，拔除引流管。术后 10 天觉右上腹不适来院复查，T 37.2℃，血 WBC 9.0×10⁹/L，N 75%，B 超发现胆囊窝处 4-5cm 液性暗区，穿刺抽出黄色液体似胆汁。最合理的处理是　时间不足,拔管过早　胆汁被大网膜包过来

答案:1-2 无 无D